

Протокол лабораторного скрининга при трудностях со снижением веса

(назначается при первичном приёме и последующем мониторинге)

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ (первичный скрининг)

1.1. Общее состояние организма

- Общий анализ крови
- Общий анализ мочи
- Креатинин, мочеви́на

1.2. Углеводный обмен

- Глюкоза натощак (8–12 ч голодания)
- Гликированный гемоглобин (HbA1c)

1.3. Инсулинорезистентность

- Инсулин натощак (совокупно с глюкозой)
- Расчет HOMA-IR (делаю сам)

1.4. Функция щитовидной железы

- ТТГ (тиреотропный гормон)
- Свободный Т4 (тироксин)

1.5. Липидный обмен

- Общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, Триглицериды (натощак)

1.6. Функция печени

- АЛТ, АСТ, ГГТ

1.7. Витаминный статус

- Витамин D (25-ОН D3)

1.8. Инструментальная диагностика

- УЗИ органов брюшной полости (печень, жёлчный пузырь, поджелудочная железа)
- Биоимпедансометрия — состав тела (% жира, висцеральный жир, мышечная масса)

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (по клиническим показаниям, после беседы)

2.1. Щитовидная железа

- Свободный Т3
- Антитела к ТПО

2.2. Воспаление и метаболизм железа

- С-реактивный белок (СРБ)
- Ферритин
- Витамин В12

2.3. Половые гормоны (женщинам)

Показания: нарушение цикла, гирсутизм, СПКЯ

- Общий тестостерон
- Свободный тестостерон
- ДГЭА-S
- ЛГ, ФСГ
- Пролактин

Сдача — на 3–5 день цикла

2.4. Половые гормоны (мужчинам)

Показания: снижение либидо, эректильная дисфункция, гинекомастия

- Общий тестостерон (утро 8–10 ч)
- Свободный тестостерон (если пограничный общий)
- ДГЭА-S

2.5. Функция надпочечников

Показания: центральное ожирение, стрии, слабость, Кушинг

- Утренний кортизол
- Суточная экскреция свободного кортизола (моча)

2.6. Специальные маркеры

- **Лептин** — при выраженном ожирении (ИМТ >35)

3. ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ

- **Первичное обследование:** полный комплекс
- **Далее:**
 - Через 3 мес: глюкоза, HbA1c, липиды, печёночные пробы
 - Через 6 мес: ТТГ, биоимпеданс
 - Раз в год: полный комплекс
- Если цель достигнута: — контроль каждые 6 мес

4. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗАМ

- Голод 8–12 часов (глюкоза, инсулин, липиды)
- Утренний забор (8–10 часов) — гормоны
- Исключить стресс для кортизола
- Женщинам — фаза цикла при гормонах

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Начинайте с обязательного минимума
- Дополнительно — по показаниям
- Избегайте «скрининга ради скрининга»
- Интерпретацию делаю я сам

 **Примечание:** Объём обследования определяется индивидуально с учётом анамнеза, клиники и возможностей пациента.